Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
1ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos

Autos nº 0808977-95.2024.8.12.0001

Classe: Procedimento Comum Cível - Oncológico

Autor:Artur Mario Medeiros Ramalho

Réu: Estado de Mato Grosso do Sul

Sentença

ARTUR MARIO MEDEIROS RAMALHO ajuizou **"Ação de Obrigação de Fazer c.c. Tutela de Urgência"** cumulada com pedido de tutela de urgência antecipada, a fim de que o ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, ambos qualificados, forneça-lhe o tratamento medicamentoso prescrito. Alega que é portadora de *Mieloma Múltiplo (CID10: C90.0 Mieloma múltiplo)* com resposta parcial ao tratamento realizado, em programação para transplante autólogo de medula óssea. Assim, foi-lhe prescrito o uso do medicamento *Daratumumabe 1800mg (Dalinvi)*. Diante da necessidade do medicamento prescrito pelo médico que lhe acompanha, além da falta de condições financeiras em arcar com os custos do tratamento e pela desídia do requerido em fornecê-lo, requereu a concessão da tutela de urgência para que lhe seja disponibilizado o medicamento acima mencionado, conforme prescrição médica. Pediu, ao final, o julgamento procedente para confirmar a obrigação de fornecer o medicamento prescrito. Requereu a justiça gratuita e juntou documentos (fls. 01/55).

Concedeu-se a tutela de urgência provisória (fls. 71/74).

Citado, o requerido apresentou contestação, na qual levantou preliminar incorreção do valor da causa e incompetência absoluta, indicando que a União deveria integrar o polo passivo, conforme Tema 793 oriundo do julgamento do RE 855.178 no âmbito do STF, IAC 14 do STJ e decisão proferida no âmbito do Tema 1234 do STF. Também discorreu quanto a responsabilidade da União pelo fornecimento de medicamentos oncológicos no

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULINNE SIMOES DE SOUZA, liberado nos autos em 18/12/2024 às 19:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808977-95.2024.8.12.0001 e código nlEzWYQ4.

SUS. No mérito, defendeu que não restou comprovada a imprescindibilidade do medicamento, nem a ineficácia do tratamento disponível no SUS. Salientou a ausência de custo-efetividade do medicamento e a responsabilidade das CACONS ou UNACONS pelo fornecimento de medicamentos especializados para o tratamento de câncer. Pediu o julgamento improcedente dos pedidos (fls. 83/104).

Em réplica, a requerente rebateu os argumentos das defesas, voltando às suas teses e pedidos (fls. 108/121).

O requerido pugnou pela solicitação de nota técnica pelo sistema nacional e-NatJus (f. 131), a autora por sua vez, propugnou pelo julgamento antecipado da lide (f. 134).

O feito foi saneado (fls.151/156).

Vieram-me conclusos para sentença.

É o relatório. **Decido**

Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que se pleiteia a condenação do requerido a lhe fornecer o medicamento denominado Daratumumabe 1800mg (Dalinvi), diante da impossibilidade de custeá-lo.

Não há preliminares ou questões processuais pendentes de decisão.

No **mérito**, verifica-se que a requerente busca que o requerido lhe forneça o medicamento Daratumumabe 1800mg (Dalinvi).

A Nota Técnica (fls. 59/70) é clara quanto à eficácia do medicamento Daratumumabe.

Todavia, apesar de registrado na ANVISA, o Comitê de Medicamentos da Conitec, na 122ª Reunião Ordinária, realizada no dia 14 de setembro de 2023, em seu Relatório Final, optou pela não inclusão do medicamento na lista do SUS, em razão do elevado impacto econômico.

Passemos à análise da Súmula Vinculante n. 61, que possui a seguinte redação:

Súmula vinculante nº 61 - A concessão judicial de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULINNE SIMOES DE SOUZA, liberado nos autos em 18/12/2024 às 19:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808977-95.2024.8.12.0001 e código nlEzWYQ4.

medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

Assim, a tese firmada no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471) preleciona:

"1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: ***(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULINNE SIMOES DE SOUZA, liberado nos autos em 18/12/2024 às 19:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808977-95.2024.8.12.0001 e código nlEzWYQ4.

científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. *3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS"* - grifo nosso

Necessária, portanto, a análise dos requisitos definidos pelo STF para a concessão do medicamento pretendido*:*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULINNE SIMOES DE SOUZA, liberado nos autos em 18/12/2024 às 19:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808977-95.2024.8.12.0001 e código nlEzWYQ4.

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1.234 da repercussão geral – não houve comprovação, todavia, ante a não incorporação do medicamento ao RENAME, é certo o indeferimento.

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011 –Tenho que tal requisito é suprido pela extensa indicação técnica médica, de modo que a não incorporação do medicamento se deu, segundo o Relatório Final da Conitec, realizado no dia 14 de setembro de 2023, na 122ª Reunião Ordinária da comissão, tão somente em razão de seu alto custo econômico. Assim, de acordo com estudos técnicos, Parecer Técnico Científico Daratumumabe para Mieloma Múltiplo (Instituto Nacional de Cardiologia, Rio de Janeiro, 03/07/2019), há comprovada eficácia do fármaco, aumento do tempo de sobrevida livre de progressão da doença.

A fundamentar tal entendimento, indico as recomendações o *Pharmaceutical Benefits Advisory Committee* (PBAC), na Austrália, o *Scottish Medicines Consortium* (SMC), na Escócia, em 2019, o *National Institute for Health and Care Excellence* (NICE), no Reino Unido, em 2019, o *Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health* (CADTH), em 2017, no Canadá e *Haute Autorité de Santé* (HAS), na França, e pelo *German Federal Joint Committee* (G-BA), na Alemanha, citados no Relatório de Recomendação de Medicamento n.º 848 da CONITEC.

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas – Comprovado pelo laudo médico de fls. 13/15.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULINNE SIMOES DE SOUZA, liberado nos autos em 18/12/2024 às 19:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808977-95.2024.8.12.0001 e código nlEzWYQ4.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
1ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
HOSPITAL REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE
R.ENGº LUTHERO LOPES,Nº36-CEP:79084-180-FONE:378-2500-FAX:386-1414-WWW.MS.GOV.BR-CNPJ: 04228734/0001-

Setor de Oncologia Adulto/Hematologia e Quimioterapia Ambulatorial

LAUDO MÉDICO

PACIENTE: ARTUR MARIO MEDEIROS RAMALHO
IDADE: 64 ANOS

O PACIENTE ACIMA TEVE O DIAGNÓSTICO DE MIELOMA MÚLTIPLO EM NOVEMBRO DE 2022 E REALIZOU TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO (PROTOCOLO VTD – BORTEZOMIBE/TALIDOMIDA/DEXAMETASONA) ATÉ JUNHO DE 2023, APRESENTANDO RESPOSTA PARCIAL AO TRATAMENTO INSTITUÍDO.

DEVIDO À RESPOSTA AO TRATAMENTO, NECESSITA DE TERAPIA PARA MELHOR CONTROLE DE DOENÇA E PROGRAMAÇÃO DE TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE MEDULA ÓSSEA.

MIELOMA MÚLTIPLO ESTÁ ASSOCIADO COM DISFUNÇÃO ORGÂNICA, INCLUINDO LESÕES ÓSSEAS, ANEMIA, INSUFICIÊNCIA RENAL E HIPERCALCEMIA. OS INIBIDORES DE PROTEASSOMA (POR EXEMPLO, BORTEZOMIBE) EM COMBINAÇÃO COM GLICOCORTICOIDES SÃO REGIMES PADRÃO PARA RECIDIVA OU RECAÍDA EM MIELOMA MÚLTIPLO REFRATÁRIO E CONTRIBUÍRAM CONSIDERAVELMENTE PARA A SOBREVIVÊNCIA DO PACIENTE, NO ENTANTO, QUASE TODOS OS PACIENTES TERÃO UMA RECAÍDA.

DARATUMUMAB É UM ANTICORPO MONOCLONAL IGG HUMANO QUE TEM COMO ALVO O CD38, QUE É ALTAMENTE EXPRESSO EM CÉLULAS DE MIELOMA E OUTROS TIPOS DE CÉLULAS HEMATOPOIÉTICAS. O DARATUMUMABE TEM EFEITO DIRETO E ATIVIDADE ANTITUMORAL INDIRETA E DIVERSOS MECANISMOS DE AÇÃO, INCLUINDO INDUÇÃO DE APOPTOSE; AÇÕES IMUNOMEDIADAS, INCLUINDO CITOTOXICIDADE DEPENDENTE DE COMPLEMENTO, DEPENDENTE DE ANTICORPOS, CITOTOXICIDADE MEDIADA POR CÉLULAS E FAGOCITOSE CELULAR DEPENDENTE DE ANTICORPOS; E FUNÇÕES IMUNOMODULADORAS QUE VISAM E EMPOBRECEM CD38.

EM PACIENTES PRÉ-TRATADOS QUE NÃO ATINGIRAM RESPOSTA COMPLETA OU COM RECIDIVA OU MIELOMA MÚLTIPLO RECIDIVANTE E

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULINNE SIMOES DE SOUZA, liberado nos autos em 18/12/2024 às 19:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808977-95.2024.8.12.0001 e código nlEzWYQ4.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
1ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos

REFRATÁRIO, DARATUMUMABE DE AGENTE ÚNICO FOI ASSOCIADO A UMA TAXA DE RESPOSTA GERAL DE 31% E UMA MEDIANA GERAL DE SOBREVIVÊNCIA DE 20,1 MESES.

COM BASE NESTES ACHADOS, MONOTERAPIA COM DARATUMUMABE EM UMA DOSE DE 16 MG POR QUILOGRAMA DE PESO CORPORAL FOI APROVADO PELA FDA PARA O TRATAMENTO DE MIELOMA MÚLTIPLO EM PACIENTES CUJA DOENÇA É REFRATÁRIA AO TRATAMENTO EM CLASSES DE DROGAS (IMUNOMOULADORES E INIBIDORES DE PROTEASSOMA).

O TRATAMENTO COM DARATUMUMAB EM COMBINAÇÃO COM INIBIDORES DE PROTEASSOMA E AGENTES IMUNOMODULADORES RESULTOU EM ALTAS TAXAS DE RESPOSTA E PERFIS DE SEGURANÇA ACEITÁVEIS NA FASE INICIAL DOS ENSAIOS CLÍNICOS.

ENTRE OS PACIENTES COM RECIDIVA OU RECAÍDA E MIELOMA MÚLTIPLO REFRATÁRIO, A COMBINAÇÃO DE DARATUMUMABE, BORTEZOMIBE E DEXAMETASONA RESULTOU EM SIGNIFICATIVO AUMENTO DO TEMPO LIVRE DE SOBREVIDA DO QUE BORTEZOMIBE E DEXAMETASONA SOZINHO, COM RISCO DE PROGRESSÃO DA DOENÇA OU MORTE QUE FOI 61,4% MENOR NO GRUPO DO DARATUMUMAB QUE NO GRUPO CONTROLE.

NO GRUPO DO DARATUMUMAB, RESPOSTAS PROFUNDAS, RÁPIDAS E DURÁVEIS FORAM RELATADAS, COM TAXAS DE MUITO BOA RESPOSTA PARCIAL OU MELHOR E COMPLETA RESPOSTA OU MELHOR, APROXIMADAMENTE O DOBRO DAQUELES DO GRUPO DE CONTROLE. A DURAÇÃO MÉDIA DA RESPOSTA E O TEMPO PARA O ANTIMIELOMA SUBSEQUENTE TERAPIA FORAM MAIS CURTOS NO GRUPO DE CONTROLE DO QUE NO GRUPO DARATUMUMAB, O QUE SUGERE QUE PACIENTES QUE RECEBERAM DARATUMUMAB TAMBÉM FORAM CAPAZES DE MANTER PERÍODOS MAIS LONGOS DE REMISSÃO.

O DARATUMUMABE SERIA APLICADO NA DOSE DE 1800MG VIA SUBCUTÂNEA, OU 16 MG/KG INTRAVENOSO, UMA VEZ NA SEMANA POR 3 SEMANAS CONSECUTIVAS (D1, D8 E D15) DURANTE OS CICLOS 1 A 3, TENDO POSTERIORES INFUSÕES A CADA 3 SEMANAS (21 DIAS) DOS CICLOS 4 A 8, E APÓS, INFUSÕES A CADA 4 SEMANAS ATÉ TOXICIDADE OU PROGRESSÃO DE DOENÇA, JUNTAMENTE COM O BORTEZOMIBE E DEXAMETASONA, ESSE ESQUEMA COMPÕE O CICLO QUE SE REPETE A CADA 21 DIAS, A PACIENTE FARIA NO MÍNIMO, 8 CICLOS.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULINNE SIMOES DE SOUZA, liberado nos autos em 18/12/2024 às 19:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808977-95.2024.8.12.0001 e código nlEzWYQ4.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
1ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos

COM RELAÇÃO A ESCOLHA DO MÉTODO DE INFUSÃO DO DARATUMUMABE, A VIA SUBCUTÂNEA FOI ASSOCIADO À MELHOR TOLERÂNCIA, COMODIDADE E RISCOS DE REAÇÕES INFUSIONAIS.

O DARATUMUMAB NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NA REDE PÚBLICA E POR ISSO ENCAMINHO O CASO PARA CONSEGUIR VIA AÇÃO JUDICIAL.

SEGUE EM ANEXO OS EXAMES, A PRESCRIÇÃO DA MEDICAÇÃO.

CID: C90.0

OBRIGADO!

Walter A. Gonçalves
CRM/MS 8678
Clínica Médica / Hematologia
RQE 7626 / 7615

DR WALTER ASSUNÇÃO GONÇALVES
CRM-MS 8678
MÉDICO HEMATOLOGISTA

CAMPO GRANDE, 16 DE JANEIRO DE 2024.

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise – Conforme citado acima, nos termos das justificativa técnica exposta da nota técnica às **fls. 54/70**, além do teor do Relatório de Recomendação da Conitec[2], o Parecer Técnico Científico Daratumumabe para Mieloma Múltiplo (Instituto Nacional de Cardiologia, Rio de Janeiro, 03/07/2019), além das recomendações em outros países, *Pharmaceutical Benefits Advisory Committee* (PBAC), na Austrália, o *Scottish Medicines Consortium* (SMC), na Escócia, em 2019, o *National Institute for Health and Care Excellence* (NICE), no Reino Unido, em 2019, o *Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health*

[2] chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2023/Relatorioderecomendacao848Daratumumabe.pdf

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULINNE SIMOES DE SOUZA, liberado nos autos em 18/12/2024 às 19:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808977-95.2024.8.12.0001 e código nlEzWYQ4.

(CADTH), em 2017, no Canadá e *Haute Autorité de Santé* (HAS), na França, e pelo *German Federal Joint Committee* (G-BA), na Alemanha.

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado – conforme laudo médico (fls. 13/14) e Nota Técnica do NAT (fls. 59/70), somado ao fato de que o medicamento não possui genérico ou similar.

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento – comprovada uma vez que deferida em favor dela a gratuidade processual, nos termos da decisão de fls. 71/74, e nos documentos de fls. 39/50, do que se presume a necessidade de custeio do tratamento pelo Poder Público.

Portanto, presentes os requisitos autorizadores, a procedência dos pedidos é medida que se impõe.

Como ressabido, é dever do Estado (em sentido amplo) fornecer o tratamento adequado, por força do art. 6º da Carta Magna, que erige a saúde e a assistência aos desamparados como direitos sociais, de modo que eventuais vedações infraconstitucionais não podem figurar como empecilho à garantia de vida digna da requerente.

É que, neste caso, a barreira que se tem é meramente burocrática e administrativa, já que a especialista que acompanha o caso específico da requerente e conhece todas as nuances do quadro clínico, indicou com precisão a necessidade de se administrar medicamento, e há respaldo técnico/científico a amparar a prescrição medicamentosa.

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, confirmo a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTE o pedido obrigação de fazer para determinar que o requerido forneça à requerente o tratamento de que necessita com o medicamento *Daratumumabe 1800mg (Dalinvi)*, conforme prescrição médica,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULINNE SIMOES DE SOUZA, liberado nos autos em 18/12/2024 às 19:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808977-95.2024.8.12.0001 e código nlEzWYQ4.

enquanto houver necessidade, inclusive com alteração de dosagem, caso necessário, mediante apresentação de receita médica atualizada.

Outrossim, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono contrário, fixados por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Deixo de condená-lo ao pagamento de custas processuais, por isenção legal.

Certificado o decurso do prazo para interposição de recurso, remetam-se ao e. Tribunal de Justiça para reexame necessário da sentença.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Oportunamente, arquive-se.

Campo Grande, data da assinatura digital.

Paulinne Simões de Souza

Juíza de Direito

(assinado por certificação digital)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PAULINNE SIMOES DE SOUZA, liberado nos autos em 18/12/2024 às 19:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0808977-95.2024.8.12.0001 e código nlEzWYQ4.